个人健康检查清单

从 5 份知识库提炼 · A4 一页纸 · 每条都写清不做的后果

> 先跑一遍，把「没做到」里挑 2–3 条改掉，其余留着下次。这份清单的价值在筛选，不在全部达成。

L0 一票否决

破一条，后面所有努力打对折

- ☐ 不吸烟（含电子烟）；吸烟的尽早戒，需要就用戒烟门诊和药物 **B**（少抽不等于风险归零）**后果** 吸烟者全因死亡高 54%（≥10 支/日）；少抽只是少一点，不是归零 · HTL 吸烟 RR 1.54（≥10 支/日）、1.17（<10 支/日）；HLB §2
- ☐ 不嚼槟榔 **C** **后果** 口腔黏膜下纤维化→张口困难，口腔癌风险上升（RR 1.21） · HTL 槟榔 RR 1.21；HLB §2
- ☐ 不酒驾、不超速；坐车前排后排都系安全带；骑电动车摩托戴盔并扣好 **后果** 交通伤是全球青壮年第一死因；后排不系带同样致命 · HLB §1
- ☐ 电动车不进楼道、不在家充电；家里装烟雾报警器；燃气软管到期就换 **后果** 楼道起火 3 分钟浓烟致命；一氧化碳中毒多发生在睡着时 · HLB §1
- ☐ 不采、不买、不吃野生蘑菇；发霉的花生玉米整包扔 **后果** 毒蘑菇无特效解药；黄曲霉素 280℃ 才分解，是强致癌物 · HTC 食品安全；HLB §1–2

L1 每天

收益最大，也最容易被熬夜和外卖吃掉

- ☐ 起床时间固定，周末也别差太多 **后果** 作息来回漂，等于每周给自己倒一次时差 · HLB §3
- ☐ 睡够 7 小时左右（6–8 小时），别靠周末补 **B**（记一周入睡/起床时间即可） **后果** 长期≥10 小时组死亡高 34–48%；睡不够伤免疫、代谢与情绪 · HTL 睡眠时长：7 小时组最低，≥10 小时组 男 HR 1.34 / 女 HR 1.48；HSO
- ☐ 起床后到户外见光 2–10 分钟（隔窗效果减半以上） **后果** 缺晨光，生物钟往后漂：晚上更难睡、白天更困 · HSO 睡眠实践
- ☐ 睡前一小时不看手机；夜里尽量少强光（23–4 点强光最伤） **后果** 夜间强光抑制多巴胺，接下来几天心情和专注都掉 · HSO；HLB §3
- ☐ 下午 2 点后不喝咖啡、浓茶（界线自己试） **后果** 咖啡因半衰期 5–6 小时，直接削掉深睡 · HLB §3；HSO
- ☐ 主食里有一部分是全谷（糙米、燕麦、全麦） **B** **后果** 全精制主食：血糖波动大、纤维不足，全谷那份收益全丢 · HTL 全谷物 RR 0.83
- ☐ 蔬菜水果每天一斤左右 **后果** 蔬果不足是归因死亡排前列的饮食风险 · HLB §2
- ☐ 每天一小把无盐坚果 **B**（替掉薯片饼干，别加量） **后果** 用零食补嘴：换来反式脂肪和热量，不是坚果那份收益 · HTL 坚果 ≥7 次/周 HR 0.80
- ☐ 不喝含糖饮料（奶茶、可乐、果汁），改白水或无糖茶咖啡 **B** **后果** 每天≥2 份全因死亡高 21%；纯果汁也不省事（1.24） · HTL 含糖饮料 HR 1.21（≥2 份/日）；纯果汁 1.24
- ☐ 火腿、香肠、培根、午餐肉基本不吃 **B** **后果** 每天多一份加工肉死亡高 3%；红肉多半份高 10% · HTL 加工肉 HR 1.03；红肉每天多半份 HR 1.10
- ☐ 炒菜从开火到做完一直开着抽油烟机（不做饭可跳过） **后果** 厨房油烟是不吸烟女性肺癌的重要暴露源 · HLB §2
- ☐ 热汤热茶放一放再喝，不喝滚烫的 **后果** 65℃ 以上热饮与食管癌相关 · HLB §2
- ☐ 一天两次天然发酵食品（无糖酸奶、kefir、纳豆、自然发酵酸菜）（要冷藏、非罐装） **后果** 菌群多样性低→免疫调节差、慢性炎症水平高 · HSO 肠道菌群与免疫
- ☐ 走到 7000 步左右 **C**（基线 +1000 起步） **后果** 不动的人死亡风险显著更高；步数是最便宜的干预 · HTL 每日步数（观察性）
- ☐ 不连续坐 1 小时以上，起来走两分钟 **B** **后果** 久坐超过 8 小时后每多 1 小时风险 +4%，运动抵不全 · HTL 久坐 RR 1.04（>8 小时/日，每多 1 小时）
- ☐ 早晚刷牙 + 每天清一次牙缝；缺的牙去补 **B** **后果** 很少刷牙者过早死亡高 25%；牙周炎牵连心血管 · HTL 刷牙：很少刷 vs 规律刷，过早死亡 HR 1.25
- ☐ 白天出门见见太阳，别整天待在屋里 **D** **后果** 白天不见光，夜里睡不好，情绪也更容易低 · HTL 户外光照（观察性支持）

L2 每周

补的不是时长，是「有强度」和「有人」

- ☐ 力量训练 2 次，覆盖主要肌群（俯卧撑、深蹲、器械都算） **B** **后果** 肌肉量 30 岁后逐年掉，衰弱和跌倒是老人致死主因之一 · HTL 抗阻训练 RR 0.85
- ☐ 中等强度有氧累计 150 分钟；有余力每周再加 15–50 分钟高强度 **B**（喘到说不了整句=高强度） **后果** 心肺适能低是最强的死亡预测指标之一 · HTL 剧烈运动 HR 0.82（15 分钟/周）/ 0.64（54 分钟/周）
- ☐ 一次挥拍、球类，或者你真心喜欢的运动 **B** **后果** 不运动者全因死亡约为常运动者的两倍（观察性） · HTL 挥拍运动 HR 0.53（观察性）
- ☐ 和亲人朋友真正见面 ≥1 次，不是心情差了才去找人 **B** **后果** 社会隔离 OR 1.29、孤独 1.26、独居 1.32——量级和吸烟同级 · HTL 社会隔离 OR 1.29、孤独 1.26；HLB §22
- ☐ 自己做饭 ≥3 顿，顶掉外卖 **C** **后果** 外卖以超加工为主，高摄入组死亡 HR 1.62 · HTC；HTL 超加工食品 HR 1.62
- ☐ 一周工作不超过 50 小时（没在上班可跳过） **后果** 长期超时工作推高血压、压缩睡眠、抬高抑郁风险 · HLB §3

L3 每年 / 按年龄

只办一次的事，最容易被「以后再说」

- ☐ 每年量血压；高了按医嘱吃药，不自行停药 **A** **后果** 高血压基本没症状，等有症状常是卒中、心衰或肾衰 · HLB §1；HTL 强化降压 HR 0.73（符合适应证者）
- ☐ 空腹血糖查一次（35 岁起，超重就提前） **后果** 糖尿病前期没感觉，十年后以并发症现身 · HLB §1
- ☐ 幽门螺杆菌查一次；丙肝抗体查一次 **C** **后果** 都是沉默的胃癌、肝硬化推手；丙肝治愈后死亡 HR 0.48 · HLB §1；HTL 丙肝治疗 HR 0.48
- ☐ 核对乙肝接种史，需要补种的补上（抗体下降不等于要重打） **后果** 乙肝是肝癌主因，没有抗体等于没有防护 · HLB §1
- ☐ 45 岁起结直肠癌筛查；女性 30 起宫颈筛查、40 起乳腺钼靶、65 起骨密度 **后果** 这几种癌早期几乎无症状，筛不出来就只能等它报警 · HLB §1
- ☐ 疫苗：流感每年（60 岁起）、带状疱疹（50 岁起）、肺炎球菌（65 岁起） **后果** 在老人身上，一次肺炎或流感常是「最后一次住院」 · HLB §1
- ☐ 记 BMI 和腰围：BMI 20–25，腰围别一路涨 **B**（BMI = 体重kg ÷ 身高m²） **后果** 腰围每 +10cm 全因死亡 HR 1.11；腹型肥胖比体重更危险 · HTL 腰围每 +10cm HR 1.11
- ☐ 长期大声打鼾、睡中憋气、白天总犯困 → 去做睡眠评估 **B** **后果** 重度睡眠呼吸暂停 HR 1.90，夜间缺氧持续伤心脏和大脑 · HTL 重度睡眠呼吸暂停 HR 1.90

L4 出事那一刻（背下来）

不靠毅力，靠提前记住；跟家里人说一遍

- ☐ 倒地、叫不应、没正常呼吸 → 立刻用力按压胸口，并让人找 AED **耽误的代价** 心脏骤停每延迟 1 分钟，存活率降 7–10% · HLB §13
- ☐ 突然嘴歪、一侧胳膊没劲 → 直接打 120，不自己开车去 **耽误的代价** 卒中每耽误 1 分钟，约 190 万个脑细胞死亡 · HLB §13
- ☐ 胸口压着疼超过 15 分钟不缓解 → 打 120 **耽误的代价** 心梗拖过黄金时间，心肌坏死不可逆 · HLB §13
- ☐ 有人噎住 → 拍背 + 腹部冲击；不满 1 岁的婴儿 → 拍背 + 按胸（婴儿不能做腹部冲击） **耽误的代价** 完全梗阻几分钟内即脑损伤，来不及送医院 · HLB §13
- ☐ 烫伤 → 先用凉的流水冲 20 分钟，不抹牙膏酱油 **耽误的代价** 不冲冷水，热力继续往深层烧；抹牙膏酱油会感染 · HLB §13
- ☐ 被猫狗咬伤或抓破皮 → 冲洗后当天去打疫苗 **耽误的代价** 狂犬病一旦发病，病死率几乎 100% · HLB §13、§8
- ☐ 误服清洁剂、农药 → 不催吐，带上瓶子去医院 **耽误的代价** 催吐造成二次灼伤；医生要知道成分才能救 · HLB §13
- ☐ 火灾 → 贴地走、先摸门温度、走楼梯不坐电梯 **耽误的代价** 浓烟 30 秒就能让人失去意识；电梯可能断电困人 · HLB §13

L5 一次性办完

每条 10 分钟内办掉，办完长期有效

- ☐ 换成低钠富钾盐 **A**（肾功能不全、吃保钾药、血钾高先问医生） **后果** 普通盐吃多推高血压，卒中风险随之上升 · HTL 死亡率比 0.88
- ☐ 浴室、楼梯装扶手和防滑；60 岁后专门练平衡和腿力 **后果** 跌倒是 65 岁以上伤害死亡第一位 · HLB §1
- ☐ 两种感冒药或止痛药不叠着吃，先看成分表对乙酰氨基酚 **后果** 叠加服用是急性肝衰竭最常见的原因之一 · HLB §34
- ☐ 普通感冒不要抗生素；吃头孢、甲硝唑期间和停药一周内不喝酒 **后果** 双硫仑样反应可致休克；抗生素还毁肠道菌群 · HLB §34
- ☐ 四季豆和豆浆要熟透，木耳别泡过夜，牛蛙田螺生鱼片要全熟 **后果** 皂苷、米酵菌酸、寄生虫都能直接进急诊 · HTC 食品安全
- ☐ 食用油备 2–3 种轮换，不重复用油，少煎炸（炒菜用芥花油、花生油、精炼橄榄油） **后果** 反复高温的油产生反式脂肪和氧化产物 · HTC 厨房准备
- ☐ 关掉手机上不必要的通知，工作时手机放到看不见的地方 **后果** 每次被打断，要十几分钟才能回到原来的思考深度 · HLB §3
- ☐ 情绪持续低落、提不起劲超过两周 → 找人求助或看医生 **C**（硬扛不算方案） **后果** 长期悲观推高全因死亡（HR 1.13），还会拖慢就医 · HLB §29；HTL 悲观 HR 1.134

省钱的「别做」

不成立的事，做了等于花钱买风险

- ☐ 别为抗衰吃 NMN **D** **做了会怎样** 钱花了，健康人延寿没有任何直接证据 · HTL：健康人无直接证据
- ☐ 别在健康状态下自行吃二甲双胍 **C** **做了会怎样** 腹泻 53% vs 12%，还可能掩盖真正的病因 · HTL：健康人延寿证据不成立
- ☐ 别常规吃复合维生素、大剂量维生素 D 求延寿 **A** **做了会怎样** 随机试验阴性（HR 0.99），高剂量维 D 还有中毒风险 · HTL：HR 0.93 / 0.99，随机试验阴性
- ☐ 别自行开始阿司匹林做一级预防 **B** **做了会怎样** 老年试验里出血更多（HR 1.14），得不偿失 · HTL：老年试验 HR 1.14，出血更多
- ☐ 长期失眠别靠褪黑素，先做认知行为治疗 **做了会怎样** 规格不受控，可能引起抑郁情绪，也没解决行为问题 · HLB §6；HSO
- ☐ 别猛补钙、喝骨头汤治骨折；感冒别要求输液 **做了会怎样** 补钙不治骨折还增结石风险；输液只增加感染和过敏机会 · HLB §6

读数字的前置说明：这些数字是人群层面的关联，不是个人因果：不同因素的 HR 不能相乘、也不能换算成「少活几年」，这正是原始资料自己反复强调的限制。清单只做筛选——做到 80% 就够，别为了最后 20% 把生活过成 KPI。危害一栏里有一部分是通用医学常识（急救时间窗、中毒机制），出处栏标的是该条「行动」本身的证据来源。

证据分级： **A** 随机对照或多队列强证据 · **B** 大型队列 / 系统综述，观察性关联 · **C** 弱关联或口径需修正 · **D** 无直接证据，别当结论 · **-** 常识性安全措施或实操建议，未做分级

来源： **HTL** HowToLiveLonger · geekan **HSO** HumanSystemOptimization · zijie0 **HLB §n** HowToLiveBetter · eternity4719 第 n 节 **HTC** HowToCook · Anduin2017

范围：本页只覆盖健康与安全。第 5 份仓库 remote-working（远程工作资料合集）属于工作方式与机会信息，不构成健康证据，未纳入；HowToLiveBetter 里的「钱」「账号与防骗」两个模块也不在本页范围。